

4

DISCAPACIDAD

// DRA. SILVIA INTRUVINI*

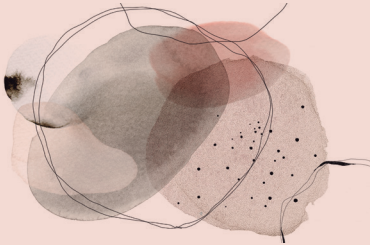
Neuropediatra.

Consultora en neurorehabilitación infantil Fleni.

Pro-Secretaria de Grupo de Discapacidad SAP.

Presidente del Comité de Discapacidad ALAPE.

* Conflicto de intereses: ninguno que declarar



JOSÉ LUIS, 15 AÑOS

Presenta microtia e hipoacusia severa derecha y con nivel auditivo normal en oído izquierdo (potenciales evocados auditivos de tronco normal y controles audiométricos normales). Antecedentes perinatólogicos normales. Neurodesarrollo normal: sin dificultades en el desarrollo del lenguaje ni trastornos del aprendizaje ni en la socialización. Cursa 2° año en escolaridad común con rendimiento promedio. Evaluación neurocognitiva normal para la edad.

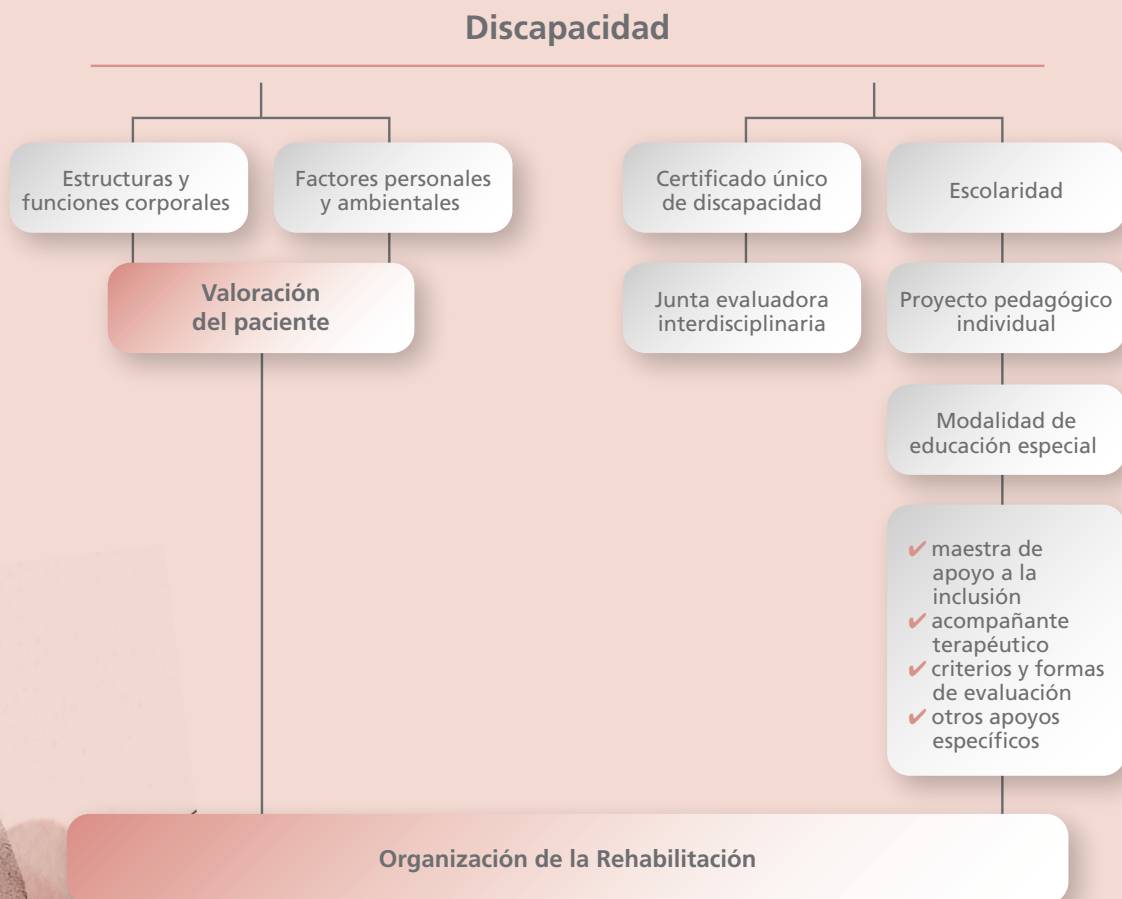
¿Se podrá conseguir el Certificado Único de Discapacidad? ¿Por qué?



OBJETIVOS

- ◆ Aplicar en la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud en la práctica clínica y en el trabajo en equipos interdisciplinarios.
- ◆ Orientar a las familias y a la comunidad en general acerca de los derechos y coberturas en salud que cuentan las personas con discapacidad.
- ◆ Sistematizar toda la información necesaria para gestionar el certificado de discapacidad.
- ◆ Recomendar a los padres la mejor trayectoria educativa para su hijo/ hija teniendo en cuenta su condición de salud y contexto.

ESQUEMA DE CONTENIDOS



GLOSARIO

APND. Acompañante personal no docente.

Atención conjunta. Capacidad de seguir la dirección de la mirada del otro o *“mirar donde alguien más está mirando.”*

AVD. Actividades de la vida diaria

CIE-10. Clasificación Internacional de Enfermedades.

CIF. Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud.

CPAP. Presión positiva continua en la vía respiratoria.

CUD. Certificado único de discapacidad.

JEI. Junta Evaluadora Interdisciplinaria.

MAI. Maestra de apoyo a la inclusión.

NOO. Neuro ortopedia.

PCD. Personas con discapacidad.

PPI. Proyecto Pedagógico Individual.

TEA. Trastorno del espectro del autismo

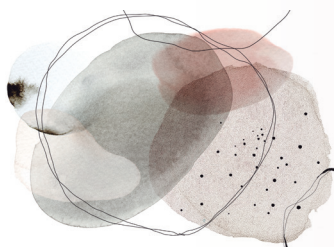
TO. Terapia ocupacional.

INTRODUCCIÓN

En diciembre 2022 la OMS publicó que, en el mundo, 1.300 millones son personas con discapacidad (PCD). Es decir que 1 de cada 6 personas o que el 16% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad.

Históricamente los Organismos Internacionales trabajaron arduamente para encontrar una definición de Discapacidad acorde a lo establecido por la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

- ✓ La OMS, en 2001, en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud refiere que la discapacidad es un término genérico que manifiesta los aspectos negativos de la interacción de un individuo con una determinada condición de salud y sus factores contextuales (factores ambientales y personales). (CIF OMS 2001).
- ✓ La ONU, en 2006, define la discapacidad como el resultado de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras, debidas a la actitud y al entorno, que dificultan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. (Convención de la ONU, 2006).



Las dos definiciones coinciden en resaltar la importancia de la interacción de las personas con el medio que los rodea, las barreras a las que se enfrentan y de los impedimentos para llevar a cabo sus actividades.

Focalizar la atención en las enfermedades o trastornos de la persona y luego en sus consecuencias no resultó suficiente para solucionar las dificultades a las que se enfrentan las PCD.

Las PCD tienen que superar barreras que impiden, por ejemplo, un pleno desarrollo de sus capacidades, el ejercicio de sus derechos y la optimización de recursos mediante políticas sanitarias.

Medir a la discapacidad es muy difícil debido a que depende de la percepción de las personas. Una deficiencia severa no genera necesariamente una discapacidad de igual magnitud. Por ejemplo, un niño con hipoacusia severa puede no tener un impedimento para el normal desarrollo de las áreas cognitivas, incluso podría cursar una carrera universitaria. Hoy se dispone de múltiples herramientas de baja complejidad que eliminarían las barreras técnicas a las que se enfrenta y que estarían a su alcance. Pero la pregunta es ¿cuánto nosotros como sociedad somos verdaderos facilitadores para que esto suceda?

Afortunadamente, nosotros podemos ser un “factor de apoyo facilitador” (formamos parte de los factores ambientales) sin importar el lugar que ocupemos en nuestra sociedad. Por último, resulta

ineludible recordar la importancia de los determinantes sociales como factores causantes de NNyA con discapacidad, un claro ejemplo es la desnutrición.

Por estas razones necesitamos conocer algunas de las herramientas disponibles para aplicarlas en la práctica clínica. Una de estas herramientas es la **Familia de Clasificaciones Internacionales de la OMS**.

FAMILIA DE CLASIFICACIONES INTERNACIONALES DE LA OMS

En las últimas décadas la OMS ha desarrollado un grupo de clasificaciones que permitieron avances en la visión de la discapacidad.

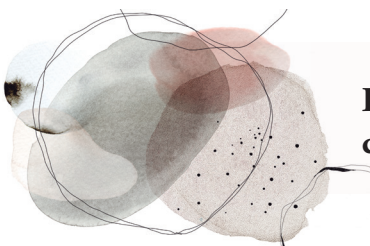
Las clasificaciones de la OMS formulan que **la discapacidad es un rango de aplicación universal** de los seres humanos y no un identificador único de un grupo social en particular.

El principio de universalidad significa que el ser humano tiene en potencia alguna limitación en su funcionamiento corporal, social o personal asociado a una condición de salud.

Es un hecho que la discapacidad en todas sus dimensiones es siempre relativa a las expectativas colocadas sobre el funcionamiento (que se espera o no, que realicen las personas). Pero esta diversidad deriva en que se requiere que dichos niveles de funcionamiento sean susceptibles de ser identificados científicamente.

Hay evidencias de como las diferencias culturales impactan en la comprensión y en la “mirada” hacia la “discapacidad” por lo que resulta inevitable que las diferentes interpretaciones de la salud y/o de la enfermedad tengan relación directa con las expectativas de las PCD y las de sus familias en relación a los tratamientos y/o el accionar de los profesionales de la salud.

¿Cómo identificar estas diferencias transculturales y lingüísticas? Es desde aquí donde surge la necesidad imperiosa de desarrollar un instrumento que las integre pero que además sea útil para comparar y compartir información entre profesionales de la salud, de educación, familia y cuidadores. Éste es otro de los objetivos de la familia de las Clasificaciones Internacionales de la OMS.



Las Clasificaciones Internacionales de la OMS son complementarias.

Las utilizadas en la actualidad son la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) y la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y Salud (CIF). Ambas son tenidas en cuenta para la emisión de certificado único de discapacidad.

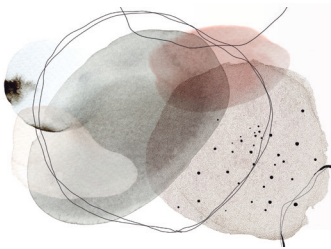
Clasificación Internacional de Enfermedades, décima edición. (CIE-10). Brinda un marco conceptual basado en la etiología. Proporciona un diagnóstico de enfermedades, trastornos o condiciones de salud. Los términos diagnósticos y de otros problemas de salud, identificados como códigos alfanuméricos facilitan su almacenamiento y posterior recuperación para el análisis de la información.

Ejemplo: Diagnóstico: Trastorno del espectro de autismo. Código CIE-10: F.84: Trastorno generalizado del desarrollo.

Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF). La CIF fue aprobada en la Asamblea Mundial de la Salud en el año 2001 y la versión NNyA en el 2008.

Se basa en el modelo biopsicosocial y universal de la OMS. Fue concebida para ser aplicada en la práctica clínica, investigación, políticas educacionales y sociales. Uno de sus objetivos primordiales fue crear un lenguaje estandarizado y único para describir la salud y los estados relacionados, facilitando la comunicación al momento de comparar información a nivel internacional, entre profesionales de distintos campos. La CIF cambia el concepto de enfermedad por condición de salud. No focaliza en las consecuencias de las enfermedades. Permite a los “usuarios” elaborar un perfil sobre el funcionamiento y discapacidad de la salud de un individuo.

Es una gran herramienta clínica para valorar al paciente a la hora de construir un plan diagnóstico, de seguimiento y/o de tratamientos de rehabilitación. Elabora un perfil de funcionamiento en todas las etapas de la evolución de la enfermedad. Es un instrumento de medida, es un sistema de clasificación. No informa cómo medir. No ayuda a definir que medir o tomar en cuenta. Promueve el cuidado, centrado en el niño y su familia.



Cabe destacar que la CIF no fue creada sólo para las personas con discapacidad (PCD) sino también para las personas sin discapacidad.

¿Cuál es el primer paso para su aplicación? Conocer su estructura básica y el conceptual de los componentes y factores contextuales.

La CIF agrupa sistemáticamente los diferentes dominios de una persona en un determinado estado de salud, asumiendo como dominio a un conjunto relevante de funciones fisiológicas, estructuras anatómicas, acciones, tareas o áreas de la vida relacionadas entre sí.

La CIF organiza la información en dos partes	
Funcionamiento y discapacidad	Estructuras y funciones corporales Participación en actividades
Factores contextuales	Factores personales Factores ambientales

El concepto de funcionamiento al igual que el de discapacidad son términos generales. Son el producto de una interacción dinámica entre la condición de salud (trastorno o enfermedad) y los componentes, los que se encuentran bajo la directa influencia de los factores contextuales.

En el caso del concepto **discapacidad** la diferencia radica en que engloba las **alteraciones de los componentes** es decir los aspectos negativos.

El modelo integrador CIF **enfatisa el rol de los factores ambientales y personales**, como elementos claves en determinar el grado de funcionamiento o discapacidad de un individuo.

La incorporación de la influencia de los mismos sobre el funcionamiento, nos muestra el potencial ilimitado que surge al planear intervenciones en NNyA con enfermedades crónicas.

No olvidar la importancia de los **factores contextuales** al planear las **intervenciones terapéuticas**.

Definiciones de los componentes y factores contextuales:

- ✓ **Funciones corporales:** son las funciones fisiológicas de los sistemas corporales, incluyendo las psicológicas.
- ✓ **Estructuras corporales:** son las partes anatómicas del cuerpo, tales como los órganos, las extremidades sus componentes
- ✓ **Deficiencias:** son problemas en las funciones o estructuras corporales, tales como una desviación significativa o una pérdida.
- ✓ **Actividad:** es la realización de una tarea o acción por parte de un individuo. Incluye capacidad y desempeño.
- ✓ **Participación:** es el acto de involucrarse en una situación vital.
- ✓ **Limitaciones en la actividad:** son dificultades que un individuo puede tener en el desempeño/realización de actividades.
- ✓ **Restricciones en la participación:** son problemas que un individuo puede experimentar al involucrarse en situaciones vitales.
- ✓ **Factores ambientales:** constituyen el ambiente físico, social y actitudinal en el que las personas viven y conducen su vida. (Individual: hogar, lugar de trabajo escuela, familia, compañeros, propiedades físicas de los lugares a que se enfrentan. Social: formales o informales de la comunidad o culturales, servicios, organizaciones).
- ✓ **Factores personales:** son las características del individuo (sexo, edad, valores culturales, estilo de vida, medio social, otros).

¿CÓMO APLICAR LA CIF EN LA EVALUACIÓN DE UN PACIENTE EN LA PRÁCTICA CLÍNICA?

En la evaluación de un paciente se deben considerar:

1) Las diferencias entre dos conceptos.

- ✓ **Desempeño:** es el acto de involucrarse en una situación vital o la experiencia vivida de las personas en el contexto real en el que viven. El contexto incluye factores

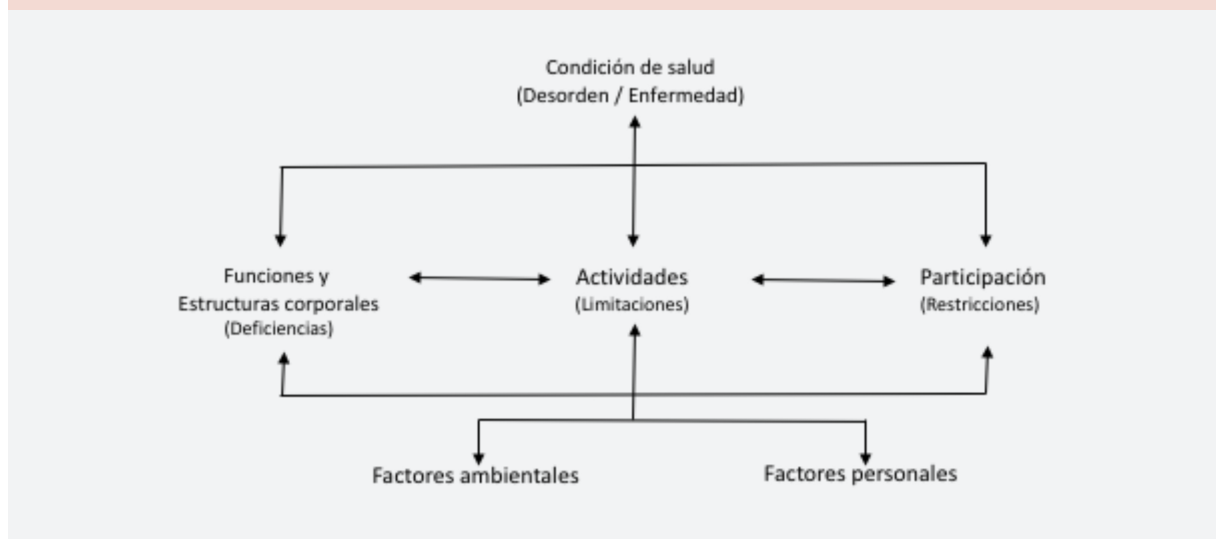
ambientales: físicos, social y actitudinal.

✓ **Capacidad:** es la aptitud de un individuo para realizar una tarea o acción.

El evaluarla requiere de un contexto normatizado que neutralice los diferentes efectos de los entornos sobre la capacidad. Pueden evaluarse con o sin dispositivos de ayuda o asistencia personal, aunque mejore o elimine los déficits.

2) **Las limitaciones o restricciones:** evaluar las posibilidades del paciente. La evaluación se realiza comparando las conductas del paciente con los estándares (conductas socialmente aceptadas) de las personas que no padecen la misma condición de salud.

Figura 1. Diagrama de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud



Fuente: OMS . Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud. (CIF). Octubre 2010.

En **primera instancia** tengamos presente que la CIF puede ser aplicada en todas las fases de una condición de salud (agudo-subagudo o crónico) en cualquier etapa del desarrollo.

En **segundo lugar**, está claro que en cada consulta clínica como médico de cabecera de un NNyA con discapacidad y/o como coordinador de equipos inter o transdisciplinarios nos encontramos ante el desafío diario de pensar desde la funcionalidad en el momento de elaborar, proyectar y/o monitorear los avances o no del tratamiento de rehabilitación.

Evidentemente no se trata de una tarea sencilla, por esta razón, es esencial organizarnos de la mejor manera posible entendiendo que no siempre contamos con el tiempo y los recursos necesarios.

En **tercer lugar**, las recomendaciones que surgen de nuestra evaluación clínica deberán ser centradas en el paciente y la familia haciendo partícipe activo de ella al NNyA. Esto requiere darles el espacio necesario en el que pueda expresar sus intereses. Otro factor fundamental en el momento de elaborar las recomendaciones es pensar en los determinantes sociales en el que están inmersos la familia y el niño/a.

El siguiente caso clínico se utilizará a modo de ejemplo sobre cómo aplicar las Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud en la evaluación de un paciente en la práctica clínica.

JULIÁN, 8 AÑOS DE EDAD

Producto de G1P1A0 embarazo controlado sin complicaciones de 38 semanas de gestación. Parto por cesárea. Peso de nacimiento: 3.800 g Deprimido grave. Requirió maniobras de reanimación. Se interna en UTI. Permanece 48 horas en ARM. Ecografía cerebral: sin evidencia de patología. La evolución y exámenes complementarios cardiológicos, respiratorios, ORL y visuales fueron normales. OEA normales. Pesquisa neonatal normal.

Alta neonatal a los 7 días de vida.

Desde el 3° mes de vida se observa espasticidad progresiva, tendencia al opistótonos frente a los cambios posturales, reflejos tónico cervical exagerado, ausencia de reacciones de defensa, hipersensibilidad oral progresiva, hipotonía axial. La espasticidad fue en franco aumento interfiriendo en el desarrollo de pautas madurativas y autonomía.

RMN de cerebro: se observa lesión en los ganglios de la base.

Actualmente presenta cuadriparesia distónica generalizada la que interfiere en todas sus actividades. Se observa retracciones musculares que limitan el movimiento y espasmos musculares los que le causan dolor.

Requiere de asistencia para la higiene, para comer y actividades de la vida diaria. No presenta alteraciones del sueño.

El nivel intelectual promedio alto. Es un niño tenaz. En la escuela es acompañado por un asistente externo. El habla es disártrica y a veces ininteligible por lo que en ocasiones requiere de un sistema aumentativo y alternativo de la comunicación (programa con salida de voz) el que le ayuda a interactuar en la escuela con los docentes y socializar con otras personas.

Se desplaza en silla de ruedas. Sus padres y sus dos hermanas lo asisten con mucho amor.

Julián comparte espacios de juego comunitario y escolar con sus amigos.

El ejercicio consiste en situarnos en cada componente y mediante preguntas sencillas ubicarnos como la condición salud (enfermedad o trastorno) de nuestro paciente afecta su vida.

En este caso **se elaborará el perfil de funcionamiento del paciente** (cual si fuera una fotografía) tomando en cuenta los siguientes ítems:

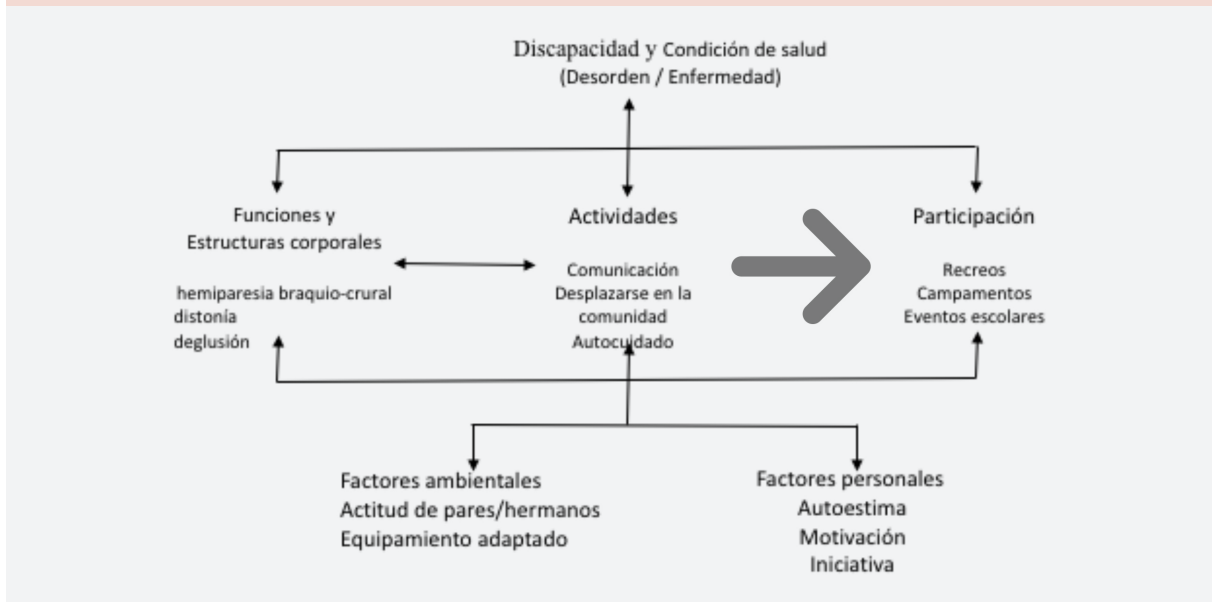
- ✓ Edad.
- ✓ Diagnóstico.
- ✓ Etapa clínica.
- ✓ Lugar donde se realice la evaluación (institución, centro de atención primaria, CABA, conurbano, etc.)

Con la información de la evaluación clínica, entrevista a la familia y la aplicación de evaluación estandarizadas se construye el **perfil de funcionamiento** del niño respondiendo a las preguntas que derivan del diagrama de la Figura N°1.

Perfil de funcionamiento de Julián.

- 1-Cuál es la **condición de salud**: Parálisis cerebral
- 2- Cuáles son las **estructuras alteradas**: cerebro
- 3-Cuál es el estado de las **funciones corporales**:
 - ✓ Intelectual, sueño, atención: sin limitaciones
 - ✓ Motivación: es tenaz
 - ✓ ¿Sensación de dolor? relacionadas con la movilidad articular, el tono muscular y control de los movimientos voluntarios: máxima deficiencia.
- 4- Cómo es la **actividad y participación**, teniendo en cuenta que la interacción entre los tres componentes es dinámica.
 - ✓ Resuelve problemas (ejemplo: frente a un problema o actividad a realizar: ¿busca soluciones, identificar las razones que le impiden o no realizarlas, evaluar opciones? SI
 - ✓ Lleva a cabo su higiene personal, alimentación o AVD. Con limitaciones
 - ✓ ¿Tiene capacidad para desplazarse? Sin limitación (con silla de ruedas) aunque el desempeño es limitado.
 - ✓ ¿Puede mantener una conversación? Sin limitaciones en la capacidad y moderadas en el desempeño.
 - ✓ Rendimiento escolar. Sin limitaciones
 - ✓ ¿Cómo son las interacciones interpersonales? (con amigos, compañeros de la escuela, familiares, etc.). Sin limitaciones
 - ✓ Participa de actividades recreativas domiciliarias y comunitarias: presenta restricciones para realizarlas sin asistencia como concurrir a campamentos escolares o paseos o en una plaza.
- 5- ¿Cómo influyen los **factores ambientales**?
 - ✓ Familiares, amigos, las actitudes sociales a las que se enfrentan, así como los dispositivos tecnológicos y equipamiento, son considerables facilitadores.
 - ✓ ¿Dónde reside?
 - ✓ ¿Con que **medios cuenta para desplazarse** a los centros de salud, educación o recreativos? (Estos datos no figuran en la historia clínica, pero deberán considerarse al momento de realizar las recomendaciones.)

Figura 2. Diagrama de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud



Fuente: Modificado . OMS . Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud. (CIF). Octubre 2010.

Resumiendo: Julián **es un niño de 8 años de edad con discapacidad** que presenta deficiencias, cuadriparesia distónica y dolor corporal, sin limitaciones en la mayoría de las actividades de la edad ni restricciones en la participación. Se dispone de escasa información de factores ambientales para planear intervenciones.

Teniendo en cuenta la importancia de la socialización y del desarrollo de la autonomía, en nuestro paciente se propusieron los siguientes dos objetivos básicos a seguir:

- ✓ Favorecer la socialización y autonomía abordando la comunicación y el autocuidado para que pueda compartir espacios propios de la edad como un campamento.
- ✓ Mejorar las deficiencias: distonía y dolor mediante tratamiento médico terapéutico para evitar que interfieran en sus actividades y participación en su vida diaria.

DESDE LA PRIMERA CONSULTA A LA ORGANIZACIÓN DEL TRATAMIENTO DE REHABILITACIÓN

En el siguiente caso clínico, se analizan los datos para elaborar un resumen para gestionar el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

AZUL , NIÑA DE 3 AÑOS Y 11 MESES DE EDAD

Previamente sana que a los 2 años de edad comenzó impotencia funcional de miembro inferior derecho. Se solicitó interconsulta con traumatología cuya impresión diagnóstica fue sinovitis de cadera. A las 24 horas agrega ataxia. Dado que 10 días antes había recibido la vacuna contra la varicela el cuadro se asume como cerebelitis pos-infecciosa.

Se solicitó RMN de cerebro la que fue normal. Se realizó punción lumbar. El cito-químico, cultivos para bacterias, virus y hongos fueron negativos; PCR en LCR fueron normales. Agrega episodios convulsivos tónicos generalizados y movimientos coreicos cuya intensidad requiere sedo- analgesia.

Impresión Diagnóstica: encefalitis con movimientos anormales. Se solicitó anticuerpos N-metil-D-aspartato (NMDA) los que resultaron positivos. El diagnóstico es encefalitis autoinmune por anticuerpos NMDA.

Al examen clínico la niña presenta una cuadriparesia espástica severa. Desde el alta sanatorial careció de controles médicos y tratamientos de rehabilitación a pesar de los esfuerzos de sus padres.

Determinantes sociales:

- Padre sin trabajo estable.
- No contaba con cobertura social.
- Nivel socioeconómico: bajo.
- Vive en el conurbano a 60 km de CABA.
- Centro de rehabilitación más cercano a 30 km.

Debido a que el padre encuentra un trabajo estable que le permite acceder a una obra social la familia pudo iniciar los controles de salud de sus hijos.

En síntesis: la etiología se conoce, el paciente cursa la etapa crónica de la enfermedad.

Valoración clínica

Se realiza la valoración por funciones y estructuras enunciadas en el primer componente de la CIF.

AZUL, 3 AÑOS Y 11 MESES DE EDAD. ESTADO CLÍNICO ACTUAL

Los datos surgen de la anamnesis y el examen físico.

Problemas activos.

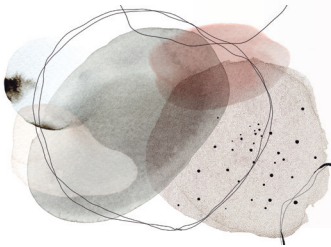
- Mentales: conectado - alerta.
- Sensoriales: sigue el objeto con la mirada sin y con comando verbal.
- Localiza los sonidos: aplauso, voces de padres o hermanos.
- Digestivo: deglución: alterada por la ingesta con semisólidos y líquidos (es grave).
- Antecedentes de infecciones pulmonares recurrentes.
- Estado nutricional. Peso: pc 3, Talla: pc 10, Perímetro cefálico: pc 25.
- Funciones esfinterianas: vejiga neurogénica. Ritmo evacuatorio: constipación crónica y dolor abdominal.
- Estado de la piel. Sin particularidades.

- Funciones neuro-músculo esqueléticas (relacionadas con el movimiento):
- Compromiso clínico: cuadriparesia, hipotonía axial. Tono muscular: espasticidad. Trofismo muscular: hipotrófico. Múltiples retracciones musculares.
- Dolor crónico: espasmos musculares.
- Sueño: alteraciones por dolor, por falta de relajación e imposibilidad de cambios posturales debido a la espasticidad.

Interconsultas médicos-terapéuticas y exámenes complementarios

Solicitar múltiples interconsultas (IC) con especialistas médicos, terapeutas y exámenes complementarios.

El desafío es elegir actuar en aquellos problemas activos que al abordarlos nos permitan avanzar en la resolución de problemas en otros sistemas. De este modo al mismo tiempo podremos iniciar la primera etapa del tratamiento de rehabilitación.



Es esencial conocer los mecanismos fisiopatológicos básicos responsables de la patología y tener presente cuál es la información que es imprescindible obtener.

Como ejemplo, en el caso de Azul se decide abordar la alteración de la deglución que Impacta básicamente en:

- Incorporación de nutrientes.
- Crecimiento y desarrollo (retraso del crecimiento).
- Alteración del metabolismo fosfocálcico.
- Producción de infecciones respiratorias recurrentes.

Bajo este planteo, se solicita:

- ✓ **Videodeglución.** Las alteraciones de la deglución son multifactoriales. Son secundaria a la incoordinación de los músculos orofaríngeos, al pobre control postural y a la fatigabilidad, observada en el paciente con espasticidad. El estudio nos proporciona una imagen dinámica del bolo alimenticio. Permite valorar aspectos anatómicos y funcionales: analizar la presencia de alteraciones en la etapa oral o faríngea, la integridad del cierre de la vía aérea antes, durante y después de la alimentación. Detectar la presencia de aspiraciones y valorar los tiempos de las etapas (esta información es imprescindible para iniciar el tratamiento sin riesgos para el paciente).
- ✓ **Interconsulta con neuro - ortopedia.** Esta consulta nos proporcionará información acerca de la correcta alineación y movilidad a nivel de la cadera y de la columna para

poder adoptar una correcta postura en sedestación. También puede evaluar el tono en las estructuras oromotoras y que intervenciones necesita para controlar su tono muscular como primera propuesta de tratamiento.

- ✓ **Evaluación kinésica infantil.** Nos dará información acerca de su control postural y motor. (patrones neuromotores). Cuánta asistencia necesita para la función, asistencia del adulto o del equipamiento para mantener una correcta postura requerida para una apropiada deglución y para maximizar su desempeño.
- ✓ **Evaluación del metabolismo fosfocálcico.** La osteopenia es una complicación frecuente a considerar secundaria a la escasa movilización, la falta descarga de peso de su propio cuerpo sobre sus pies y a las alteraciones nutricionales. Su importancia radica en la posibilidad de que se produzcan fracturas espontáneas o ante la movilización. Es vital que la familia, terapeutas y cuidadores cuenten con dicha información. También lo es que el kinesiólogo/a entrene en maniobras específicas para ser utilizadas en las transiciones en los diferentes planos, durante la higiene, el juego o traslados.

Las evaluaciones clínicas (médicas y terapéuticas) y estudios solicitados también nos proporcionan información anexa que nos permite actuar más allá del motivo inicial de la solicitud de los mismos. Por ejemplo, en el caso de nuestro paciente veamos la evaluación neuro-ortopédica y la evaluación kinésica.

- ✓ **Evaluación neuro-ortopédica infantil.** El objetivo de una evaluación neuroortopédica (NOO) es prevenir deformidades y dolor. La luxación de caderas es uno de las deformidades más frecuentes en niños con espasticidad. Se desarrolla con el crecimiento. La inestabilidad de las caderas por desbalance de músculos genera deformidades en el acetábulo, limitaciones en la movilidad y dolor con impacto en la sedestación e higiene. El pobre control de tronco por debilidad muscular, inadecuada sedestación anteversión o retroversión de pelvis y por las alteraciones del tono muscular como espasticidad lleva a la producción de la escoliosis. En la medida que progresan se instala la deformidad torácica y un patrón pulmonar restrictivo.
- ✓ **Evaluación kinésica.** Aporta información del nivel de funcionamiento de ese niño, cuanta asistencia requiere en las transiciones y desplazamientos. Si es independiente o no. Si se desplaza con equipamiento (andador, bastones) o si lo hace en silla (auto-propulsión, a motor o es transmovilizado). Nos da información de la conducta motriz, ósea, qué patrones de movimiento utiliza, que tipo de tono posee, que componentes de movimiento tiene y cuales aún no ha desarrollado, como es su equilibrio y coordinación. También evalúa la calidad de la respuesta y cómo es su nivel de atención conjunta y planificación motora para que la ejecución sea más adecuada. Partiendo de la evaluación clínica de los factores productores de patología de la deglución por medio de dos estudios complementarios y dos interconsultas se pueden evitar complicaciones y comenzar con tratamiento rehabilitador.

AZUL, 3 AÑOS Y 11 MESES DE EDAD

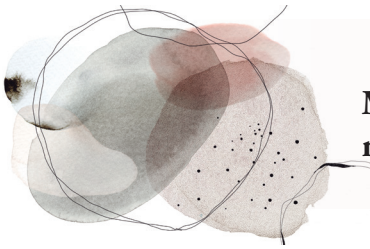
La próxima consulta se programa con el resultado del estudio de video deglución para avanzar con el tratamiento de fonoaudiología, y si fuera posible con los informes de NOO y kinesiología.

Con los informes de las evaluaciones, comenzar el intercambio entre los profesionales que hasta este momento componen el equipo.

Se decide comenzar con el tratamiento de terapia ocupacional, fonoaudiología y kinesiología.

Tratamiento de rehabilitación

Ante todo, la rehabilitación como tal no puede ser abordada por una única especialidad terapéutica por esta razón se requiere de un equipo liderado por el médico pediatra de cabecera. Se espera que el equipo esté conformado por los profesionales estrictamente necesarios de acuerdo a los problemas más importantes a abordar.

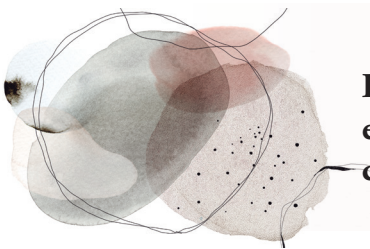


Más tratamientos terapéuticos o interconsultas no son igual a mejores resultados.

Como coordinadores del equipo de rehabilitación tenemos que tener claro qué significa funcionar como un equipo interdisciplinario.

Un equipo que trabaja de este modo es aquel donde los profesionales, médicos y terapeutas, exponen la información para tomar decisiones en torno a objetivos comunes y/o para resolver problemas complejos.

Todos se complementan entre sí para optimizar el trabajo. De esto se desprende que la figura de coordinador es esencial para organizar y facilitar el proceso.



La planificación del tratamiento rehabilitador se basa en el establecimiento de metas. Las decisiones se toman en forma colectiva luego de un exhaustivo análisis.

Las evaluaciones médicas y terapéuticas podrán realizarse por separado, pero de su conjunto deberá surgir el **“nivel de funcionamiento” y los objetivos terapéuticos integrales a abordar.**

La organización del plan de tratamiento, es decir, la elección de las terapias a recomendar, número de sesiones semanales se basarán en su resultado.

¿Cuáles serían las preguntas básicas en cada evaluación?

- Terapia ocupacional

El objetivo: evaluar habilidades manuales.

- ✓ Como manipula los objetos con ambas manos.
- ✓ ¿Cuál es el entorno?
- ✓ Los objetos están a su alcance, ya que el paciente se verá afectado por el grado de dificultad de la motricidad gruesa.
- ✓ ¿Con equipamiento o adaptaciones de objetos logra el objetivo?
- ✓ ¿Puede manipular objetos para alimentarse?
- ✓ ¿Como es la ideación y planificación para jugar?

- Fonoaudiología

Objetivo: Comunicación en la vida cotidiana.

- ✓ ¿Cuán efectiva es la comunicación en la vida cotidiana?
- ✓ ¿La comunicación mejora según los ámbitos en los que se desarrolle: hogar o escuela?
- ✓ ¿Puede tomar el lugar de receptor o emisor o ambos en todos los ámbitos? ¿Requiere de receptores familiares o cercanos (amigos) para lograrlo?
- ✓ ¿Comunica aquello que desea con o sin ayuda de un adulto o usando gestos, expresiones o un dispositivo de comunicación aumentativa alternativa?

- Kinesiólogía

Objetivo: Evaluar los componentes de la motricidad gruesa usando el juego.

- ✓ ¿Cómo se mueve para resolver problemas?
- ✓ ¿Cómo es la atención y la coordinación?
- ✓ ¿Anticipa?
- ✓ ¿Requiere de equipamiento para desplazarse?

En pediatría ninguna evaluación puede ser rígida. Por ejemplo, un profesional de terapia ocupacional tomará en cuenta cómo el paciente se comunica para expresar que requiere de ayuda para tomar un objeto, así como, el profesional fonoaudiólogo/a conocerá como posicionarlo en una silla postural para favorecer la atención del niño/a en las actividades propuestas.

Para finalizar, el proceso de rehabilitación en un paciente con discapacidad es dinámico al igual que el neurodesarrollo, evitar las complicaciones médicas también es un objetivo necesario en el proceso. Diferenciar las variaciones en la expresión clínica vs la progresión de una condición de salud, puede ser difícil. Es en el seguimiento continuo el que permite detectar las dificultades que podrán ser discutidas y resueltas. Es necesario que médicos y terapeutas que componen el equipo interdisciplinario de rehabilitación mantengan una comunicación suficientemente fluida para lograr tal fin.

DIAGNÓSTICO TEMPRANO

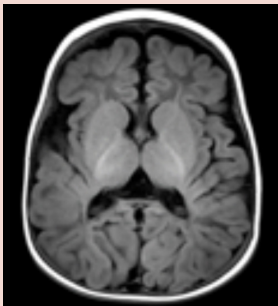
Se presentan dos casos para ejemplificar la importancia en la prevención o mejora de la discapacidad.

MARTÍN, 15 MESES DE EDAD

A los 10 meses presentó severo retraso en la adquisición de pautas madurativas, sin complicaciones perinatológicas. Al examen físico se encontró severa hipotonía generalizada, pobre conexión con el medio, contacto visual intermitente. Comenzó tratamiento de estimulación temprana.

✓ En el control de los 15 meses se observó clara mejoría en las áreas emocional- social y lenguaje evidenciadas en un adecuado contacto visual, y en una clara intención comunicativa. No se observó una mejora consistente en el área motriz gruesa.

✓ Considerando el cuadro clínico se solicitó RMN de cerebro la que evidencia alteración de la sustancia blanca. Se realizó estudio neuro metabólico para descartar errores congénitos del metabolismo y panel genético para patología de la sustancia blanca. Este último arrojó como diagnóstico: alteración del complejo 3 de la cadena respiratoria.



Axial FLAIR



Coronal T2

RMN de cerebro: en ambas figuras se observa áreas de hiperintensidad que compromete a la sustancia blanca peri-ventricular posterior en forma bilateral

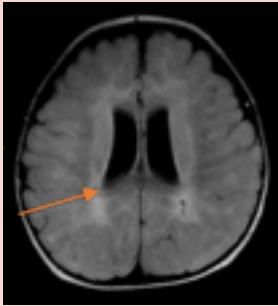
El paciente continúa en tratamiento, adquiriendo pautas madurativas sin complicaciones clínicas. Este es un ejemplo del impacto positivo en el neurodesarrollo de un niño al implementar el tratamiento rehabilitador más allá del diagnóstico etiológico.

PEDRO, 10 MESES DE EDAD

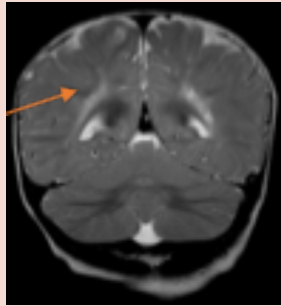
Antecedente a destacar: 35 semanas de gestación, peso de nacimiento: 1,95 Kg. APGAR 8/9. Internado 28 días. Requirió dobutamina, cafeína 12 días, CPAP 3 días, LMT 2 días, valor máximo de la bilirrubina 8,2 mg/dl. No se realiza pesquisa neonatal ampliada. Antecedentes familiares: su madre tiene trombofilia, Von Willebrand y celiaquía. Hermano fallecido a los 5 días de vida por hipertensión pulmonar severa por DAP y CIA.

A los 10 meses fue evaluado encontrándose al examen físico falta de fijeza de la mirada, hipotonía severa, hiperreflexia osteotendinosa generalizada. Agrega epilepsia. Se solicitó estudio metabólico. Los resultados fueron compatibles con aciduria metil malónica.

Esta enfermedad cuenta con tratamiento que permite evitar las secuelas si se diagnóstica precozmente. Esta enfermedad puede detectarse con el pesquisa neonatal ampliada.



RMN de cerebro: corte axial: se observa alteración de la señal de la sustancia blanca hemisférica en forma difusa y simétrica. No se identifica compromiso de los ganglios de la base

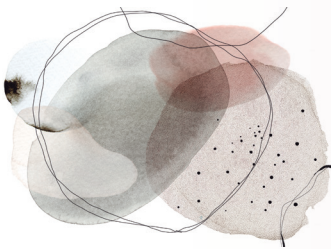


RMN de cerebro: corte sagital: se observa severo adelgazamiento del cuerpo caloso

DISCAPACIDAD Y ESCOLARIDAD

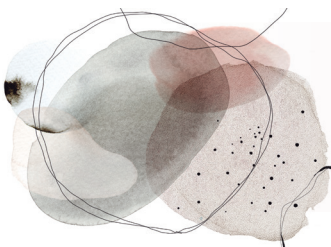
Argentina adhirió, en carácter de jerarquía constitucional, a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el año 2014.

El Consejo Federal de Educación sancionó en el año 2016 la Resolución N° 311 que establece las bases de la educación inclusiva en todo el territorio argentino.



“Las escuelas tienen prohibido rechazar la inscripción o reinscripción de un/a estudiante por motivos de discapacidad. El rechazo por motivo de discapacidad, de forma directa o indirecta, será considerado un acto de discriminación”.(Resolución N° 311)

Otra de sus premisas fundamentales es basar todas las acciones del sistema educativo en el **Modelo Social de la Discapacidad** que implica modificar prácticas y organizaciones de las instituciones educativas para atender a la diversidad de necesidades educativas de todos los y las estudiantes.



No es necesario contar con CUD para acceder a los apoyos que brinda la Modalidad Especial.

Trayectoria Educativa

En primera instancia tenemos que tener presente que todas las trayectorias son flexibles.

Sin intervención de la Modalidad Especial	La sola determinación de un diagnóstico y/o certificación de discapacidad no implica la intervención de la Modalidad especial Se insta a la organización institucional, en el Nivel que corresponda, a encontrar las mejores adecuaciones para la trayectoria de un estudiante
Orientaciones de la Modalidad Especial	El NNyA no se matriculará en la institución de Educación Especial y se brindarán orientaciones a los docentes y Equipo de Orientación Escolar del Nivel pertinente

Ejemplos de la Modalidad Especial. Sofía y Mateo

SOFÍA, 6 AÑOS DE EDAD

Diagnóstico de Hipoacusia unilateral neurosensorial con implante coclear desde los 2 años. Con acompañamiento de Fonoaudiología desde edad temprana, tiene lenguaje acorde a edad cronológica tanto en plano sintáctico como pragmático. Desde la Modalidad de Educación Especial se orienta a ubicación en el aula cerca del docente, repetir consigna general en forma individual, apoyo visual (imágenes de cuentos, por ejemplo) para todas las tareas a todos los estudiantes, utilización de portadores de texto para todos los estudiantes en las paredes del salón y en los bancos.

Proyecto Pedagógico Individual (PPI). La Propuesta Pedagógica de Inclusión, especifica las pautas, las etapas de implementación, las orientaciones para la toma de decisiones, las que se plasman en un plan de acciones diferenciadas y complementarias para la organización de la enseñanza.

Incluye la definición de prioridades para resolver configuraciones de apoyos.

Este proyecto implica la participación activa de la Modalidad Especial quien define los apoyos específicos, los criterios y formas de evaluación, y la concurrencia de una Maestra de Apoyo a la Inclusión (MAI) a una institución del nivel Inicial, Primario o Secundario como par pedagógica del/ los docentes en horarios estipulados.

Además, se registra la necesidad de la concurrencia a colegio especial a contraturno. Ambos equipos deberán detectar las barreras para configurar las estrategias necesarias para la eliminación de las mismas. Según estipula la resolución 311/16, se deben considerar:

- Barreras al acceso físico.
- Barreras de la comunicación.
- Barreras didácticas: procesos de enseñanza-aprendizaje.
- Barreras sociales/actitudinales: actitud de los docentes, de los demás estudiantes, de los familiares, carencias en la información, capacitación, conocimiento de los procesos inclusivos.

Modalidad de Educación Especial. Puede determinarse en conjunto con los equipos intervinientes, la familia y el estudiante, que la mejor trayectoria educativa para un NNyA sea la concurrencia a una modalidad de Educación Especial. En este ámbito se garantizará también un proyecto individual, atendiendo a las particularidades y se propiciaría la concreción de espacios curriculares compartidos con las instituciones del Nivel o modalidades correspondientes. También debe entenderse como un camino posible, y a veces, transitoria.

Acompañante externo, Acompañante personal no docente (APND), Acompañante terapéutico (según la jurisdicción). Se trata de un profesional que acompaña al estudiante en cualquiera de los niveles como estrategia para sobrellevar barreras no pedagógicas. Asistirá en tareas de higiene, alimentación, traslado, participación social, entre otras. Este acompañamiento debe ser solicitado y autorizado por el Sistema Educativo. Sus honorarios están a cargo de las obras sociales o prepagas de los estudiantes. La solicitud debe ser confeccionada por médico tratante. Su objetivo central es lograr creciente autonomía del estudiante. No todo estudiante con discapacidad y/o con PPI requiere de un acompañamiento de esta naturaleza.

MATEO 4 AÑOS DE EDAD

Presenta como diagnóstico de encefalopatía crónica no evolutiva secundaria a Sme. de West. Requiere silla postural para mantenerse en posición para actividades del jardín y desplazamientos. Comunica agrado y desagrado con gestos de su cara. Presenta movimientos distónicos. Está en tratamiento con Kinesiología. Fonoaudiología y Terapia Ocupacional. Fonoaudiología evalúa el posible uso de sistema alternativo aumentativo de comunicación, también aborda el primer tiempo de la deglución.

Comienza Nivel Inicial segundo Ciclo por lo que se solicita proyecto de inclusión que implica:

- La MAI concurre tres veces por semana para brindar configuraciones de apoyo particulares a cada área pedagógica.
- La docente del área de Educación Física de la Modalidad Especial brinda configuraciones en este aspecto.
- Un Acompañante Externo para colaborar en los desplazamientos por el jardín con la silla de ruedas, en el momento de la colación ya que ha recibido instrucción de la Fonoaudiología (problema de deglución) y en el cambiado de pañales ya que no controla esfínteres.

CERTIFICADO ÚNICO DE DISCAPACIDAD

El certificado único de discapacidad (CUD) es un documento oficial que acredita la condición de discapacidad por una alteración física, sensorial, mental o visceral, permanente o transitoria. No evalúa la condición de salud. Evalúa las secuelas transitorias o permanentes. Es de valor Nacional.

Es emitido por la Junta Evaluadora Interdisciplinaria previa evaluación clínica del paciente a partir del resumen de la historia clínica y de los tratamientos que recibe. Es decir, los profesionales de la

salud que conforman la Junta Evaluadora Interdisciplinaria son los que determinan si corresponde o no la emisión del CUD.

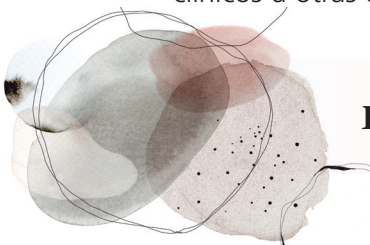
La Junta Evaluadora Interdisciplinaria (JEI) no evalúa al paciente en el período agudo de su enfermedad, internado o no, o antes de los tres meses de finalizado el episodio agudo. Recordemos que lo que define la condición de discapacidad son las alteraciones de la estructura y función, limitaciones funcionales y restricciones en la participación.

¿Cuál es el modelo en el que se basa el CUD? ¿Cuáles son las diferencias entre los tres modelos de abordar la discapacidad?

Modelo médico	Se centra en la enfermedad más que en el bienestar del individuo como persona. Concepto Salud = ausencia de enfermedad
Modelo social	Considera la discapacidad como una consecuencia de barreras medioambientales, sociales y actitudinales que no permiten a las personas con disfunciones participar plenamente en la sociedad
Modelo biopsicosocial	• Salud - enfermedad son un continuo • Objetivo: inclusión social • Énfasis en la rehabilitación integral • Marco interdisciplinario y entorno accesible
El CUD se basa en el modelo biopsicosocial.	

Documentación solicitada. Según reglamentación vigente el paciente deberá llevar a la evaluación:

- ✓ Resumen médico actualizado. Es de suma importancia que se especifique de modo claro y detallado los **diagnósticos** (funcional y etiológico) que presenta el paciente, así como los tratamientos que recibe y las **secuelas**.
En el CUD se verán reflejados los diagnósticos y las prestaciones médico terapéuticas. Hay que tener presente que de los datos registrados en el CUD depende la cobertura de la obra social o medicina prepaga.
- ✓ Exámenes complementarios realizados en los últimos 6 (seis) meses relacionados con el diagnóstico y seguimiento del paciente.
- ✓ Informes de cada uno de los profesionales del equipo terapéutico. De la información expresada en dichos informes deberá surgir el diagnóstico funcional del paciente.
- ✓ DNI.
- ✓ Las planillas según diagnóstico (discapacidad intelectual-epilepsia- discapacidad visual-auditiva entre otras). Las mismas pueden ser firmadas por médicos pediatras, clínicos u otras especialidades.



El CUD puede ser denegado de modo permanente o temporal.

En supuesto caso que el CUD sea denegado la JUI emitirá un informe y la familia del NNyA podrá pedir un segundo turno para tramitarlo.

El 03/03/2023 el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad resuelve si se otorga sin sujeción de plazo temporal alguno (resolución 322/2023).

DERECHOS

Cabe destacar que todos pacientes tienen derecho a solicitar el CUD. El CUD le permite a las PCD acceder a sus derechos y beneficios según las leyes 22.431 y 24.901.

Derechos
1. Cobertura al 100% de los tratamientos de rehabilitación
2. Cobertura al 100% de medicamentos, equipamiento, que requiera según la condición de salud expresada en el CUD
3. Cobertura de apoyos educativos
4. Pase libre de transporte urbano, interurbano y territorio nacional (Decreto N°38/2004 y N°118/09)
5. Símbolo internacional de accesos: libre tránsito y estacionamiento con total prescindencia del automotor en el cual se traslade. La Ley N°19.279, modificatorias y Decreto N° 1313/93)

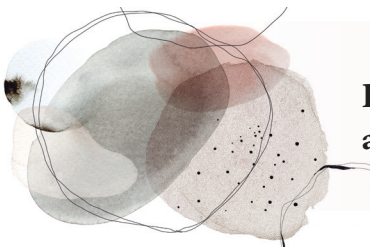
Se puede obtener un ejemplar del formulario del CUD en el siguiente link.

<https://www.argentina.gob.ar/cud/planilla-cud>

¿Quiénes conforman la Junta Evaluadora Interdisciplinaria?

La JEI puede estar conformada por médicos y terapeutas licenciados de cualquier especialidad relacionada con la rehabilitación a excepción de psicomotricidad. En el momento de la evaluación de un paciente siempre debe estar presente un médico.

El CUD es firmado por tres profesionales, ejemplo: un médico y dos terapeutas, pero siempre debe contar con la firma de un médico.



Para la emisión del CUD la Junta Evaluadora Interdisciplinaria aplica dos clasificaciones: CIE-10 y la CIF.

NAHUEL, 4 AÑOS DE EDAD

Diagnóstico de parálisis cerebral. Es producto de G1P0A0, parto eutócico, RNTPAEG, APGAR 9/10. A las 24 horas de vida presenta hipoglucemias de difícil control durante los primeros 15 días de vida.

Los padres realizan la primera consulta a los 24 meses de edad por retraso en la adquisición de la marcha e hipertonía generalizada.

A los 4 años de edad presenta diplejía espástica, requiere de equipamiento para desplazarse. Alteraciones fonológicas que no le impiden comunicarse ni incorporar aprendizajes.

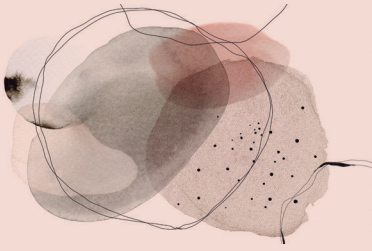
Tratamiento actual: kinesioterapia, terapia ocupacional y fonoaudiología dos veces por semana.

Diagnósticos: G80.1 Parálisis cerebral (diplejía espástica).

F80.9 Trastorno del desarrollo del habla y lenguaje.

F81. Trastorno del aprendizaje.

Bajo el código F.81 de la CIE-10 enunciado como: Trastorno específico del desarrollo de las capacidades escolares incluye el ítem “déficits del aprendizaje”.



Autoevaluación

A. Lea atentamente cada enunciado y marque V si considera que es verdadero y F si es Falso.

Enunciados	V	F
1. Naciones Unidas ha definido la discapacidad como el resultado de la interacción entre la persona con deficiencias y las barreras que dificultan su participación plena y efectiva en la sociedad.	☐	☐
2. Los factores ambientales y personales son elementos claves que determinan el grado de funcionamiento o discapacidad de un individuo.	☐	☐
3. Una persona puede tener una discapacidad de modo temporal.	☐	☐
4. Una deficiencia severa genera necesariamente una discapacidad de igual magnitud.	☐	☐
5. Es imprescindible contar con el diagnóstico etiológico para delinear un plan específico de rehabilitación.	☐	☐
6. En Argentina, por resolución ministerial, las escuelas tienen prohibido rechazar la inscripción o reinscripción de un/a estudiante por motivos de discapacidad.	☐	☐
7. El Modelo Social de la Discapacidad implica modificar prácticas y organizaciones de las instituciones educativas para atender a la diversidad de necesidades educativas de todos los estudiantes.	☐	☐
8. Es necesario contar con certificado único de discapacidad para acceder a los apoyos escolares que brinda la Modalidad Especial.	☐	☐
9. El Proyecto Pedagógico Individual (PPI) es una propuesta de inclusión que especifica las pautas a seguir y define un plan de acciones diferenciadas y complementarias para la organización de la enseñanza. Incluye la definición de prioridades para resolver configuraciones de apoyos (maestra de inclusión, acompañante externo, acompañante terapéutico, entre otros)	☐	☐
10. El certificado único de discapacidad es un documento oficial que acredita la condición de discapacidad por una alteración física, sensorial, mental o visceral, permanente o transitoria. Es extendido por el médico tratante.	☐	☐

- B. En la grilla siguiente, encuentre las siguientes palabras:**
acceso, diagnóstico, discapacidad, diversidad, escolaridad, especial,
funcionamiento, inclusión, neuroplasticidad, rehabilitación, secuelas.
Las palabras se leen en forma horizontal y/o vertical. Ejemplo: acceso

N	E	U	R	O	P	L	A	S	T	I	C	I	D	A	D	K	J	H	P	I
A	S	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	I	Z	W	Y	X	N
S	C	A	N	T	O	T	R	I	S	M	O	S	M	U	V	E	N	T	O	C
C	O	L	O	R	F	U	N	C	I	O	N	A	M	I	E	N	T	O	Ñ	L
A	L	C	A	N	F	O	R	T	U	N	A	Z	H	I	R	I	N	A	S	U
M	A	D	E	R	A	S	I	N	D	I	A	G	N	O	S	T	I	C	O	S
A	R	D	E	N	D	E	N	V	I	D	I	A	F	I	I	E	L	T	R	I
C	I	G	A	D	I	S	C	A	P	A	C	I	D	A	D	B	P	A	D	O
T	D	I	A	R	O	P	O	R	T	A	N	T	E	H	A	R	O	C	A	N
C	A	M	A	R	O	E	N	S	U	E	Ñ	O	F	I	D	E	O	C	O	Z
I	D	E	A	S	E	C	U	E	L	A	S	P	I	N	T	A	D	E	B	O
F	I	D	E	O	P	I	N	T	A	D	A	S	C	A	LL	E	G	S	O	N
A	RR	I	R	E	H	A	B	I	L	I	T	A	C	I	O	N	L	O	Z	A
R	I	C	A	N	A	L	Q	R	T	Y	K	K	L	P	W	D	H	I	J	A

C. Lea cada situación clínica y responda las preguntas

• NICOLÁS, 14 AÑOS DE EDAD

Diagnóstico de retinosis pigmentaria.

Esta enfermedad tiene curso y sintomatología variable en cada persona. Nicolás completó el Nivel Primario sin dificultades, pero últimamente ha presentado dificultades en la visión periférica que le generan “torpeza” en el desenvolvimiento diario. Además, le atemoriza desplazarse solo en el ámbito escolar y en los traslados fuera de su casa. Se implementaron estrategias para facilitar su inclusión escolar, por ejemplo mejorando la iluminación en el salón de clases.

Ud., como médico de cabecera ¿Recomendaría que se implemente PPI con maestra de inclusión?
 ¿Por qué?

.....

.....

.....

• **IGNACIO, 4 AÑOS DE EDAD**

Diagnóstico de Trastorno del espectro del autismo (TEA) desde los 2 años y medio. Concorre a fonoaudiología y terapia ocupacional (TO). Convive con sus padres y tiene familia ampliada teniendo contacto con sus primos casi todos los fines de semana. En estos últimos meses ha logrado sostener con su familia juegos de normas sencillas.

Se comunica con palabras. Ha mejorado su atención conjunta. Requiere anticipación de rutinas con pictogramas. Tiene adecuaciones brindadas por TO (banda entre las patas de la silla, chaleco de peso) para sostener actividades de mesa y silla. Comienza Nivel Inicial con estas medidas de acompañamiento ya establecidas y tras período de adaptación logra cada vez más sostener actividades planteadas por las docentes. A veces requiere que la docente se acerque a convocarlo y explicarle la consigna dada de manera individual. La docente también implementó pizarra con pictogramas para todos los niños del aula para explicar la rutina diaria y semanal. El Equipo completo del Jardín diseñó organigrama para acompañar a la docente en el aula en caso de que Ignacio manifieste angustia con llanto y berrinche ante frustraciones.

Como médico de cabecera ¿cuál sería su recomendación?

.....

.....

.....

CONCLUSIONES

Como médicos pediatras nos encontramos día a día con el desafío de dar soluciones a los problemas que enfrentan las familias con NNyA con discapacidad.

Es nuestra responsabilidad realizar un diagnóstico temprano para iniciar lo más temprano posible el tratamiento de rehabilitación.

Es importante que el pediatra conozca las disposiciones oficiales sobre el Certificado único de discapacidad para orientar a las familias en relación a los derechos en materia de apoyo escolar, medicación y tratamientos de rehabilitación.

El instrumento de mayor eficacia en la atención de estos pacientes es el equipo de trabajo interdisciplinario.

LECTURAS RECOMENDADAS

- Schiaritti Verónica et. al .Discapacidad Infantil en un mundo cambiante: enfoque de derechos humanos. (Child disability in a changing world: a human rights approach). Revista Facultad de Ciencias Médicas (Córdoba, Argentina). 2021; 78 (2): 95-96.
- Silvio Rivero. Discapacidad e Inclusión. Enfoque integral. Abordaje interdisciplinario. Editorial Letra viva. Buenos Aires. 2021.
- Lavanchy Joyce. Clasificación internacional del funcionamiento, de la discapacidad y de la salud (CIF) y su aplicación en rehabilitación. Rehabil.integral. 2011; 6(1):33-45.

CLAVE DE RESPUESTAS

A. Lea atentamente cada enunciado y marque V si considera que es verdadero y F si es Falso

- 1-2-3-6-7-9- Verdadero.
- 4. Falso. Una deficiencia severa NO genera necesariamente una discapacidad de igual magnitud. Hoy se dispone de múltiples herramientas de baja complejidad que pueden eliminar las barreras. Es importante recordar que los determinantes sociales (prejuicios, abandono, ignorancia, entre otros) son factores causantes de discapacidad.
- 5. Falso. No es imprescindible esperar los resultados de todos los estudios. Las prontas intervenciones optimizarán el uso de la neuroplasticidad, permitirá maximizar los resultados, minimizar las complicaciones y brindar el soporte adecuado a la familia.
- 8. Falso. NO ES necesario contar con certificado único de discapacidad para acceder a los apoyos escolares que brinda la Modalidad Especial.
- 10. Falso. EL CUD es emitido por la Junta Evaluadora Interdisciplinaria previa evaluación clínica del paciente, presentación de la historia clínica y de la información sobre los tratamientos que recibe.

B. Ubicar palabras

N	E	U	R	O	P	L	A	S	T	I	C	I	D	A	D	K	J	H	P	I
A	S	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	I	Z	W	Y	X	N
S	C	A	N	T	O	T	R	I	S	M	O	S	M	U	V	E	N	T	O	C
C	O	L	O	R	F	U	N	C	I	O	N	A	M	I	E	N	T	O	Ñ	L
A	L	C	A	N	F	O	R	T	U	N	A	Z	H	I	R	I	N	A	S	U
M	A	D	E	R	A	S	I	N	D	I	A	G	N	O	S	T	I	C	O	S
A	R	D	E	N	D	E	N	V	I	D	I	A	F	I	I	E	L	T	R	I
C	I	G	A	D	I	S	C	A	P	A	C	I	D	A	D	B	P	A	D	O
T	D	I	A	R	O	P	O	R	T	A	N	T	E	H	A	R	O	C	A	N
C	A	M	A	R	O	E	N	S	U	E	Ñ	O	F	I	D	E	O	C	O	Z
I	D	E	A	S	E	C	U	E	L	A	S	P	I	N	T	A	D	E	B	O
F	I	D	E	O	P	I	N	T	A	D	A	S	C	A	LL	E	G	S	O	N
A	RR	I	R	E	H	A	B	I	L	I	T	A	C	I	O	N	L	O	Z	A
R	I	C	A	N	A	L	Q	R	T	Y	K	K	L	P	W	D	H	I	J	A

C. Lea cada situación clínica y responda las preguntas

- José Luis, 15 años de edad. Toda familia puede solicitar el CUD presentando un resumen de la historia clínica del paciente. La familia solicita y la Junta Evaluadora Interdisciplinaria resuelve si otorga o no el Certificado único de discapacidad.
- Nicolás, 14 años de edad. Se recomienda la implementación de un PPI con maestra de inclusión porque podría facilitar el proceso de aprendizaje. Además, se deberían eliminar las barreras físicas que limitan el acceso a los distintos ámbitos escolares.
- Ignacio, 4 años de edad. La recomendación es escolaridad en el nivel inicial sin intervención de Modalidad de Educación Especial. Eventualmente necesitaría un acompañante externo si en algunas situaciones requiere que alguien lo acompañe fuera del aula durante un tiempo hasta calmarse.